

DOI: 10. 13288/j. 11-2166/r. 2025. 17. 018

标准与规范

类风湿关节炎病证结合诊疗指南（2025 年）

中华中医药学会《类风湿关节炎病证结合诊疗指南》项目组



[摘要] 近年来随着诊疗观念的发展、循证医学证据和国内外指南的更新，项目组遵循循证医学原则，通过文献检索客观评价中医病证结合诊治证据，并经专家充分讨论，修订、更新了2018年制定的《类风湿关节炎病证结合诊疗指南》中医证候诊断标准及治疗方案内容，形成了《类风湿关节炎病证结合诊疗指南(2025年)》，为类风湿关节炎的中医诊疗提供依据。

[关键词] 类风湿关节炎；病证结合；诊疗指南

类风湿关节炎（rheumatoid arthritis, RA）是一种常见的自身免疫性疾病，以对称性多关节炎为主要临床表现，以关节滑膜慢性炎症、关节的进行性破坏为特征。其基本病理改变为慢性滑膜炎和血管翳，可侵蚀软骨和骨，造成关节破坏。RA因其长病程和高致残率，可严重影响患者工作能力和生活质量，对患者和家属造成重大的生理、心理和经济影响。

RA属于中医学“痹病”范畴，中医诊断为“尪痹”^[1]。中医药在RA的辨证论治、个体化用药、非药物治疗、调摄养护等方面积累了丰富的临床经验和循证证据，可以预防及延缓RA病情的发展，改善症状和体征，延缓关节破坏及脏腑损害，降低疾病活动，提高患者生活质量。中华中医药学会风湿病分会于2018年制定《类风湿关节炎病证结合诊疗指南》^[2]，自发布以来在临床上得到了广泛的应用。由于近年来诊疗观念的发展、循证医学证据和国内外指南的更新，经中华中医药学会立项（项目编号：20231212-BZ-CACM），项目组再次组织相关中医、中西医结合专家，通过对数十年来中医治疗RA文献的检索、梳理，经过科学循证与充分讨论，在遵循中医理论、辨证论治原则基础上制定了《类风湿关节炎病证结合诊疗指南（2025年）》（以下简称本指南）。本指南中的证据质量和推荐意见分级采用评估、制定和评价（GRADE）分级系统^[3]，具体形成方法见附件（请扫描本文二维码获取）。本指南修订、更新了RA中医证候诊断标准及治疗方案的内容，以期为临床医师提供

RA中医标准化处理策略与方法，对中医药治疗RA的临床与科研起到指导作用。本指南已在国际实践指南注册平台（Practice guideline REgistration for transPAREncy, PREPARE）进行注册（注册号为PREPARE-2024CN744）。

1 范围

本指南适用于类风湿关节炎（ICD-11编码：FA20）^[4]的诊断、辨证、治疗、疗效评价和健康管理，适合临床一线中医师、中西医结合医师、全科医师使用。

2 诊断标准

参照1987年美国风湿病学会（American College of Rheumatology, ACR）发布的RA分类标准^[5]与2010年ACR/欧洲抗风湿病联盟（European League Against Rheumatism, EULAR）的RA分类标准^[6]进行诊断。

3 流行病学特征

RA患病人数占世界总人口的0.24%~1.0%^[7]，中国的患病率为0.28%~0.4%^[8]。RA可以发生于任何年龄，女性高发年龄为45~54岁，男性随年龄增加而发病率上升，男女比例约为1:4^[9]。调查显示，病程1~5年、>5~10年、>10~15年及>15年的我国RA患者致残率分别为18.6%、43.5%、48.1%、61.3%^[10]。RA患者的死亡率比普通人群高50%~60%^[11-13]，主要死因是心血管疾病、呼吸系统疾病和感染^[11]。

4 具体内容

4.1 临床问题 1: RA 的治疗目标是什么?

推荐意见 1: 治疗以达到临床缓解或低疾病活动度, 减少或延缓关节破坏及脏腑损害, 提高患者生活质量, 降低残疾为目标。(共识意见)

RA 是以侵蚀性、对称性多关节炎为主要表现的一种自身免疫性疾病, 2022 年 EULAR 明确提出, RA 的治疗目标是使每位患者都达到持续缓解或低疾病活动度, 即 28 个关节疾病活动度评分 (DAS28) ≤ 3.2 或临床疾病活动度指数 (CDAI) ≤ 10 或简化疾病活动指数 (SDAI) ≤ 11 [14]。RA 患者可出现动脉粥样硬化、心肌功能障碍、间质性肺炎和肌少症等合并症, 针对 RA 前阶段预防合并症具有重要意义 [15]。通过早期抗炎等治疗, 以上关节外表现发病率明显下降 [16]。此外, 对于慢性疾病管理, 除了延长寿命之外, 医疗保健的最终目标是提高生活质量。一项横断面研究显示, 通过控制疾病进程可提高 RA 患者的生活质量, 并改善疾病影响范围 [17]。

4.2 临床问题 2: RA 的中医病机是什么, 其致病因素有哪些?

推荐意见 2: 基本病机为正虚邪实。正气不足, 外感风寒湿热等病邪, 化生痰瘀, 痹阻筋骨关节甚或脏腑。(共识意见)

中医学认为, 脏腑虚损、正气不足是 RA 发病的重要内因, 由于正气不足、风寒湿热等外邪侵袭, 内外合邪痹阻关节经络, 化生痰浊瘀血流注关节而发病; 与脏腑失调、气血津液运行失常等多因素有关 [18]。RA 发病早期多表现为外感风寒湿, 痹阻经络证; 活动期证候以邪气盛实者居多, 湿热瘀阻是活动期 RA 的核心证候; 缓解期病机以正虚邪实为主, 证型多见虚实夹杂证 [19]; 后期本虚渐显现, 多肝肾不足、气血两虚证。脾胃失调、湿邪为患是本病病情迁延难愈的重要病因。痹病必夹瘀, 瘀既是病理产物又是致病因素且贯穿病程始终 [20]。

4.3 临床问题 3: RA 的治疗原则是什么?

推荐意见 3: 中医治疗以扶正祛邪、三因制宜为基本原则。早期诊断、早期治疗、选择适宜的中医综合治疗方案或中西医结合方案是病情控制的关键。(共识意见)

RA 的临床治疗中当兼顾祛邪与扶正, 即祛邪不宜攻伐过猛, 以免损伤正气; 且扶正不宜峻补, 以防邪气壅滞。三因制宜, 即因人、因时、因地制

宜, 治疗方案选择应充分考虑患者年龄、性别、体质、共病及季节、生活环境, 结合疾病分期、疾病活动度、预后不良因素及医患共同决策等, 进行中医综合治疗或中西医结合治疗。

4.4 临床问题 4: RA 患者如何准确辨证?

推荐意见 4: 常见八个证候类型, 分别是风湿痹阻证、寒湿痹阻证、湿热痹阻证、痰瘀痹阻证、瘀血阻络证、气血两虚证、肝肾不足证及气阴两虚证, 各证型具备主症 2 项, 或主症 1 项+次症 2 项, 结合舌、脉即可诊断。临床除出现单一证候, 也可出现两证或三证夹杂等复合证候。(共识意见)

4.4.1 风湿痹阻证

主症: 1) 关节疼痛、肿胀, 游走不定; 2) 关节疼痛、肿胀, 时发时止。

次症: 1) 恶风, 或汗出; 2) 头痛; 3) 肢体沉重。

舌脉: 舌质淡红, 苔薄白, 脉滑或浮。

4.4.2 寒湿痹阻证

主症: 1) 关节冷痛, 触之不温, 皮色不红; 2) 疼痛遇寒加重, 得热痛减。

次症: 1) 关节拘急, 屈伸不利; 2) 肢冷, 或畏寒喜暖; 3) 口淡不渴。

舌脉: 舌体胖大, 舌质淡, 苔白或腻, 脉弦或紧。

4.4.3 湿热痹阻证

主症: 1) 关节肿热疼痛; 2) 关节触之热感, 或自觉热感, 或关节局部皮色发红。

次症: 1) 发热; 2) 心烦; 3) 口渴或渴不欲饮; 4) 小便黄。

舌脉: 舌质红, 苔黄腻或黄厚, 脉弦滑或滑数。

4.4.4 痰瘀痹阻证

主症: 1) 关节肿痛日久不消; 2) 关节局部肤色晦暗, 或有皮下结节。

次症: 1) 关节肌肉刺痛; 2) 关节僵硬变形; 3) 面色黧黯; 4) 唇暗。

舌脉: 舌质紫暗或有瘀斑, 苔腻, 脉沉细涩或沉滑。

4.4.5 瘀血阻络证

主症: 1) 关节刺痛, 疼痛部位固定不移; 2) 疼痛夜甚。

次症: 1) 肢体麻木; 2) 关节局部色暗; 3) 肌肤甲错或干燥无泽。

舌脉: 舌质紫暗, 有瘀斑或瘀点, 苔薄白, 脉沉细涩。

4.4.6 气血两虚证

主症: 1) 关节酸痛或隐痛, 伴倦怠乏力; 2)

面色不华。

次症：1) 心悸气短；2) 头晕；3) 爪甲色淡；4) 食少纳差。

舌脉：舌质淡，苔薄，脉细弱或沉细无力。

4.4.7 肝肾不足证

主症：1) 关节疼痛，肿大或僵硬变形；2) 腰膝酸软或腰背酸痛。

次症：1) 足跟痛；2) 眩晕耳鸣；3) 潮热盗汗；4) 尿频，夜尿多。

舌脉：舌质红，苔白或少苔，脉细数。

4.4.8 气阴两虚证

主症：1) 关节肿大伴气短乏力；2) 肌肉酸痛，口干眼涩。

次症：1) 自汗或盗汗；2) 手足心热；3) 形体瘦弱，肌肤无泽；4) 虚烦多梦。

舌脉：舌质淡红或有裂纹，苔少或无苔，脉沉细或细数。

推荐意见 5：辨证准确是临床疗效的关键，诊断要点应抓住主症。在疾病的发生、发展过程中，患者在不同阶段可呈现不同证候，具有证候个体化、动态演变的特点。(共识意见)

疾病病程进展中证候迁移、演变的特性为“动态时空”特征^[21]，即证候的动态演变规律。RA 病程较长，病情缠绵，每一阶段证候特点截然不同。基于全国 18 个中心 1388 例 RA 患者的横断面研究^[22]显示，不同证型 RA 患者疾病活动度存在差异，风湿痹阻证、气血两虚证患者以中活动度为主，湿热痹阻证、痰瘀痹阻证、肝肾不足证、寒湿痹阻证以高活动度为主，其中湿热痹阻证疾病活动度最高。另外，长病程患者更多见痰瘀痹阻证、肝肾不足证。

4.5 临床问题 5：RA 如何辨证选择方剂进行治疗？

推荐意见 6：推荐选择有效古方及具有循证研究证据的现代方药进行辨病、辨证治疗，可根据患者实际情况选择确有疗效的中药加减，药物剂量可参考《中华人民共和国药典》。(共识意见)

4.5.1 辨证论治的方药

1) 风湿痹阻证 治法：祛风除湿，通络止痛。

推荐方药 1：蠲痹汤（《医学心悟》）加减^[23-27]（证据级别：C，推荐强度：弱）。功效：祛风除湿，散寒通络。主要药物组成：羌活、独活、秦艽、当归、川芎、甘草，海风藤、桑枝、肉桂、乳香、木香。加减：风气胜者，重用秦艽，加防风；寒气胜者，加附子；湿热胜者，加防己、萆薢、薏

苡仁；兼有湿热者，去肉桂，加苍术、黄柏等。临床应用侧重于风寒湿邪痹阻肢体、经络，以风邪为甚的 RA 患者。改善结局：有效率、中医证候积分、疼痛视觉模拟量表（VAS）、关节疼痛数量、晨僵时间。

推荐方药 2：大秦艽汤（《素问病机气宜保命集》）加减^[28]（证据级别：D，推荐强度：弱）。功效：祛风清热，养血活血。主要药物组成：秦艽、羌活、独活、防风、川芎、白芷、细辛、黄芩、生地黄、熟地黄、石膏、当归、白芍、茯苓、甘草、白术。加减：若无内热，去黄芩、石膏等；若表证不显，减细辛、白芷、防风等；若心下痞，加枳实等。临床应用侧重于风湿热邪痹阻肢体、经络的 RA 患者。改善结局：有效率。

推荐方药 3：羌活胜湿汤（《内外伤辨惑论》）加减（共识意见）。功效：祛风胜湿。主要药物组成：羌活、独活、藁本、防风、川芎、蔓荆子、甘草。加减：湿邪较重、肢体酸楚甚者，加苍术、细辛等；郁久化热者，加黄芩、黄柏、知母等。临床应用侧重于风寒湿邪痹阻肢体、经络所致，以湿邪为甚的 RA 患者。

2) 寒湿痹阻证 治法：温经散寒，祛湿通络。

推荐方药 1：乌头汤（《金匮要略》）加减^[29]（证据级别：C，推荐强度：弱）。功效：温经散寒，除湿宣痹。主要药物组成：川乌、麻黄、白芍、黄芪、甘草。加减：病在上肢者，加秦艽、桑枝；病在下肢者，加桑寄生、牛膝；寒甚痛剧者，加草乌、桂枝；病久有瘀血者，加乳香、没药、延胡索、红花、全蝎、蜈蚣、乌梢蛇；寒阻痰凝、兼麻木者，加半夏、桂枝、胆南星、防风；肝肾亏虚、关节畸形者，加当归、牛膝、枸杞子、熟地黄等；寒湿在表、素体阳虚者，加麻黄、附子、细辛。临床应用侧重于寒湿痹阻肢体、经络，寒象为甚的 RA 患者。改善结局：有效率、红细胞沉降率（ESR）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）。使用时应注意乌头为峻猛有毒之品，若出现唇舌肢麻，甚至昏晕吐泻，为瞑眩反应；若呼吸急促、心悸、脉搏间歇，甚或昏迷，为中毒反应。

推荐方药 2：桂枝芍药知母汤（《金匮要略》）加减^[30-31]（证据级别：B，推荐强度：强）。功效：通阳行痹，祛风逐湿，和营止痛。主要药物组成：桂枝、白芍、麻黄、生姜、白术、知母、防风、附子、甘草。加减：风盛者，倍麻黄；寒盛者，倍附子；湿盛者，倍白术；化热明显者，加忍冬藤；痛

甚者,加全蝎、蜈蚣等。临床应用侧重于风寒湿痹、邪有化热之象或寒热错杂的 RA 患者。改善结局:有效率、关节肿胀数、晨僵时间、双手握力。

3) 湿热痹阻证 治法:清热除湿,活血通络。

推荐方药 1: 宣痹汤(《温病条辨》)加减^[32](证据级别: B, 推荐强度: 强)。功效: 清热除湿, 宣痹通络。主要药物组成: 防己、薏苡仁、杏仁、滑石、连翘、栀子、半夏、蚕沙、赤小豆皮。加減: 骨节痛甚者, 加姜黄、海桐皮; 湿热较重者, 加苍术、黄柏。临床应用侧重于湿热痹阻经络、热重湿轻的 RA 患者。改善结局: DAS28 评分、ESR、CRP。

推荐方药 2: 当归拈痛汤(《医学启源》)加減^[33](证据级别: B, 推荐强度: 强)。功效: 利湿清热, 疏风止痛。主要药物组成: 羌活、茵陈、猪苓、泽泻、黄芩、苦参、人参、白术、苍术、防风、升麻、葛根、当归、知母、甘草。加減: 若络脉痹阻、肢节痛甚者, 加姜黄、海桐皮、豨莶草; 若湿停关节、肢体沉重者, 加防己、木瓜、威灵仙。临床应用侧重于湿热痹阻经络、湿重热轻者或风湿热痹的 RA 患者。改善结局: DAS28 评分、关节肿胀数、关节疼痛数、晨僵时间。

推荐方药 3: 清热活血方加減^[34-36](证据级别: B, 推荐强度: 强)。功效: 清热祛湿, 活血止痛。主要药物组成: 土茯苓、金银花、赤芍、丹参、麸炒苍术、黄柏、醋莪术、青风藤等。临床应用侧重于 RA 湿热痹阻证。改善结局: DAS28 评分、ACR 定义的风湿关节炎 20% 改善率标准(ACR20)、改良 Sharp 评分(TSS)。

推荐方药 4: 四妙消痹汤加減^[37](证据级别: B, 推荐强度: 强)。功效: 清热解毒, 利湿通痹, 柔筋利节, 活血止痛。主要药物组成: 金银花、当归、玄参、甘草、白花蛇舌草、山慈菇、豨莶草、虎杖、土茯苓、白芍、威灵仙、萆薢。加減: 湿重者加汉防己, 阴虚者加生地黄, 关节疼痛明显者加蜈蚣, 脾胃虚弱者加白术。临床应用侧重于 RA 活动期湿热毒痹证。改善结局: 有效率、关节疼痛评分、关节肿胀评分、晨僵时间。

推荐方药 5: 清络饮加味加減^[38](证据级别: D, 推荐强度: 弱)。功效: 清络舒筋, 散结止痛, 祛风除湿。主要药物组成: 苦参、青风藤、萆薢、黄柏。加減: 气血亏虚加炙黄芪、炒当归, 湿热较重加蒲公英、白花蛇舌草, 病程较长加全蝎、蜈蚣。临床应用侧重于 RA 湿热痹阻证。改善结局:

VAS 评分、晨僵时间、关节压痛指数、关节肿胀指数。

4) 痰瘀痹阻证 治法: 化痰通络, 活血行瘀。

推荐方药: 双合汤(《万病回春》《杂病源流犀烛》)加減^[39-41](证据级别: D, 推荐强度: 弱)。功效: 活血化瘀, 祛痰通络。主要药物组成: 当归、川芎、白芍、生地黄、陈皮、半夏、茯苓、桃仁、红花、白芥子、甘草。加減: 若皮下有结节, 加胆南星、天竺黄; 若瘀血甚者, 加三棱、莪术、土鳖虫; 若痰瘀胶结、肢体麻木, 加白花蛇舌草、全蝎、蜈蚣。临床应用侧重于痰瘀痹阻, 见关节肿大、僵硬、变形, 手足麻痹的 RA 患者。改善结局: DAS28 评分、关节疼痛数、关节肿胀数、晨僵时间、中医证候积分。

5) 瘀血阻络证 治法: 活血化瘀, 通络止痛。

推荐方药: 身痛逐瘀汤(《医林改错》)加減^[42-44](证据级别: D, 推荐强度: 弱)。功效: 活血化瘀, 祛风除湿, 通络止痛。主要药物组成: 秦艽、川芎、桃仁、红花、甘草、羌活、没药、当归、五灵脂、香附、牛膝、地龙。加減: 气虚者加党参、黄芪; 风甚者加威灵仙、防风; 寒甚者加川乌、细辛、附子、威灵仙; 湿甚者加薏苡仁、茯苓; 病变发生在上肢, 加桑枝、桂枝; 在项背, 加葛根; 在腰腿, 加续断、桑寄生、狗脊; 热痹者皮肤出现红斑, 去羌活、秦艽、川芎, 加黄柏、苍术、金银花; 出现关节僵直、骨节畸形, 加蜂房、全蝎、乌梢蛇; 湿热阻痹心络的心痹者, 去羌活、秦艽、牛膝、川芎, 加金银花、黄连、郁金等。临床应用侧重于关节刺痛、疼痛部位固定不移、疼痛夜甚的患者。改善结局: DAS28 评分、VAS 评分、中医证候积分。

6) 气血两虚证 治法: 益气养血、通经活络。

推荐方药 1: 黄芪桂枝五物汤(《金匮要略》)加減^[45](证据级别: B, 推荐强度: 强)。功能: 益气养血, 温经通痹。主要药物组成: 黄芪、桂枝、白芍、生姜、大枣。加減: 血瘀者加三七、丹参、三棱、川芎等。临床应用侧重于关节酸痛或隐痛, 伴倦怠乏力、面色不华的患者。改善结局: 有效率、晨僵时间。

推荐方药 2: 归脾汤(《重订严氏济生方》)加減^[46-47](证据级别: D, 推荐强度: 弱)。功能: 益气补血, 健脾养心。主要药物组成: 白术、茯神、黄芪、龙眼肉、酸枣仁、人参、木香、甘草。加減: 寒甚加附子、桂枝; 热重加白花蛇舌草、白

茅根、连翘；湿重加泽兰、猪苓；瘀重加桃仁、丹参、红花；肌肉或关节肿痛、屈伸受限，加独活、威灵仙、青风藤或姜黄；关节压痛、晨僵，加防风、炙麻黄或桂枝。临床应用侧重于关节酸痛或隐痛，伴倦怠乏力、面色不华的患者。改善结局：DAS28 评分、ACR20、汉密顿抑郁量表(HAMD)评分。

7) 肝肾不足证 治法：补益肝肾，蠲痹通络。

推荐方药 1：独活寄生汤(《备急千金要方》)加减^[48-49] (证据级别：B，推荐强度：强)。功能：祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。主要药物组成：独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、白芍、生地黄。加减：痛感剧烈者加乳香、川乌、白花蛇舌草；湿邪较盛者加防己、薏苡仁、熟地黄；脾虚者加白术、砂仁；寒邪较盛者加附子、干姜。临床应用侧重于关节疼痛、肿大或僵硬变形，腰膝酸软或腰背酸痛的患者。改善结局：有效率、晨僵时间、中医证候积分。

推荐方药 2：三痹汤(《妇人良方大全》)加减^[50-51] (证据级别：C，推荐强度：弱)。功能：益气活血，补肾散寒，祛风除湿。主要药物组成：续断、杜仲、防风、肉桂、细辛、人参、茯苓、当归、白芍、甘草、秦艽、生地黄、川芎、独活、川牛膝。加减：寒甚者加干姜、附子；痛甚者加威灵仙、延胡索；瘀血甚者加红花、桃仁；肾虚者加狗脊、鹿角霜；肾阴虚者加枸杞子、熟地黄、菟丝子、桑椹。临床应用侧重于关节疼痛、肿大或僵硬变形，腰膝酸软或腰背酸痛的患者。改善结局：DAS28 评分、临床止痛起效时间、中医证候积分。

推荐方药 3：补肾祛寒治尪汤加减^[52-55] (证据级别：C，推荐强度：弱)。功效：补肾壮骨，祛寒除湿，活血通络。主要药物组成：续断、补骨脂、熟地黄、骨碎补、淫羊藿、白芍、桂枝、独活、威灵仙、防风、麻黄、苍术、知母、伸筋草、赤芍、土鳖虫、川牛膝。临床应用侧重于 RA 肾虚寒盛证。改善结局：DAS28 评分、VAS 评分、健康评估问卷残疾指数(HAQ-DI)评分、TSS 评分、中医证候积分。

8) 气阴两虚证 治法：养阴益气，通络止痛。

推荐方药：四神煎(《验方新编》)加减^[56-57] (证据级别：C，推荐强度：弱)。功效：益气养阴，清热解毒，活血祛瘀，利水消肿，通利关节。主要药物组成：黄芪、远志、牛膝、石斛、金银花。加减：湿热盛者加黄柏、薏苡仁、秦艽；上肢

痛者加桂枝、羌活、五加皮；下肢痛者加独活、桑寄生、杜仲；关节红肿者加土茯苓、千年健；四肢痛甚者加蜈蚣、延胡索、白花蛇舌草。临床应用侧重于关节疼痛、肿大或僵硬变形，腰膝酸软或腰背酸痛的患者。改善结局：DAS28 评分、VAS 评分、HAQ-DI 评分、中医证候积分。

4.5.2 辨病论治的中药 雷公藤性寒，味苦、辛，具有祛风湿、活血通络、消肿止痛、杀虫解毒的功效，不论内服、外用都显示出显著的临床疗效。使用时应关注毒副作用，如生殖系统的毒副作用、肝毒性、肾毒性、消化系统毒副作用等。育龄期妇女或有生育要求的男性患者禁用或全面权衡利弊后遵医嘱使用，儿童、妊娠期和哺乳期妇女禁用。在辨证论治的基础上，可以合理使用雷公藤制剂新风胶囊^[58-59] (证据级别：B，推荐强度：弱)、五藤汤加减^[60-63]等(证据级别：D，推荐强度：弱)。

4.6 临床问题 6：RA 如何辨证选择中成药进行治疗？

推荐意见 7：可采用中成药进行辨病治疗，依据疾病活动度不同，推荐单独应用或联合其他治疗方案。辨病治疗意指基于 RA 诊断直接选择中成药品种，不需要对患者进行严格辨证，详见风湿病分会制定并发布的《中成药治疗类风湿关节炎临床应用指南(2022 年)》^[64]。

雷公藤多苷[貳]片^[64] (证据级别：B，推荐强度：强)。使用条件：非育龄期或育龄期无生育要求的成年 RA 患者的辨病治疗。临床应用：中/高疾病活动度者可联合传统合成改善病情抗风湿药物(csDMARDs)等常规药物应用，中/低疾病活动度者可单独应用。改善结局：DAS28 评分、ACR 定义的类风湿关节炎 20%、50%、70% 改善率标准(ACR20/50/70)。

昆仙胶囊^[64] (证据级别：C，推荐强度：强)。使用条件：非育龄期或育龄期无生育要求成年 RA 患者。临床应用：中/高疾病活动度者可联合甲氨蝶呤治疗，中/低疾病活动度者可单独应用。改善结局：DAS28 评分、HAQ-DI 评分。

正清风痛宁片/缓释片^[64] (证据级别：C，推荐强度：弱)。使用条件：非青藤碱过敏的 RA 患者。临床应用：中/高疾病活动度者可联合 csDMARDs 等常规药物治疗，低疾病活动度者可单独应用。改善结局：DAS28 评分、ACR20/50、HAQ-DI 评分、VAS 评分、肿胀关节数、晨僵时间。

白芍总苷胶囊^[65] (证据级别：B，推荐强度：弱)。使用条件：RA 患者。临床应用：联合改善病

情抗风湿药物 (DMARDs) 等常规药物治疗。改善结局: DAS28 评分、晨僵时间、关节肿胀数、关节压痛数。

推荐意见 8: RA 中成药的辨证治疗可分成祛风散寒除湿剂、化瘀祛湿剂、清热除湿剂、扶正祛湿剂四类, 具体应用需辨证论治。

1) 祛风散寒除湿剂

寒湿痹片^[66] (证据级别: D, 推荐强度: 弱)。使用条件: 寒湿痹阻证, 症见肢体关节疼痛、疲困或肿胀、局部畏寒者。功能主治: 祛寒除湿, 温通经络。临床应用: 联合 csDMARDs 等常规药物或单独应用。改善结局: 有效率、疼痛程度、肿胀程度、晨僵时间、关节活动度。

盘龙七片^[64, 67] (证据级别: C, 推荐强度: 弱)。使用条件: 风寒湿痹阻证、瘀血阻络证, 症见关节游走性或间断性疼痛、关节怕冷、遇寒加重、遇热痛减, 可伴有肌肉拘急、屈伸不利。功能主治: 祛风除湿, 活血化瘀, 消肿止痛。临床应用: 联合甲氨蝶呤片和美洛昔康片等常规药物。改善结局: DAS28 评分、VAS 评分、晨僵时间、双手平均握力。

通痹胶囊^[68] (证据级别: C, 推荐强度: 弱)。使用条件: 寒湿闭阻、瘀血阻络、气血两虚证, 症见关节冷痛、屈伸不利。功能主治: 祛风胜湿, 活血通络, 散寒止痛, 调补气血。临床应用: 联合 csDMARDs 等常规药物或单独应用。改善结局: 有效率、微循环指标 [血管阻力指数 (RI)、舒张期峰值速度 (EDV) 以及收缩期峰值速度 (PSV)]。

通络开痹片^[69] (证据级别: C, 推荐强度: 弱)。使用条件: 寒热错杂、瘀血阻络证, 症见关节疼痛、肿胀。功能主治: 祛风通络, 活血散结。临床应用: 单独应用或联合常规药物。改善结局: DAS28 评分、CDAI、VAS 评分、中医证候积分、HAQ-DI 评分。

罗浮山风湿膏药^[70] (证据级别: B, 推荐强度: 强)。使用条件: 风湿痹阻证, 症见关节肿痛。功能主治: 祛风除湿, 消肿止痛。临床应用: 联合 csDMARDs 等常规药物。改善结局: VAS 评分、关节肿胀程度、超声影像学评价。

祖师麻膏药^[71] (证据级别: D, 推荐强度: 弱)。使用条件: 风寒湿痹、瘀血痹阻证, 症见肢体关节肿痛、畏寒肢冷, 局部肿胀有硬结或瘀斑者。功能主治: 祛风除湿, 活血止痛。临床应用: 联合 csDMARDs 等常规药物。改善结局: 有效率、

VAS 评分、晨僵时间、腕关节功能活动度、腕关节超声病变检出率。

2) 化瘀祛湿剂

瘀血痹片/胶囊/颗粒^[64] (证据级别: C, 推荐强度: 弱)。使用条件: 瘀血痹阻证, 症见肌肉关节剧痛、痛处拒按、固定不移, 有结节或瘀斑。功能主治: 活血化瘀, 通络止痛。临床应用: 联合 csDMARDs。改善结局: 有效率、VAS 评分、肢体麻木症状、合并心血管疾病风险。

3) 清热除湿剂

四妙丸^[64] (证据级别: D, 推荐强度: 弱)。使用条件: 湿热痹阻证, 症见关节肿热疼痛, 关节触之热感或自觉局部发热, 或兼身热、口渴、小便黄。功能主治: 清热利湿。临床应用: 联合 csDMARDs 等常规药物。改善结局: 关节肿胀数、关节压痛数、晨僵时间。

湿热痹冲剂^[72] (证据级别: D, 推荐强度: 弱)。使用条件: 湿热痹证, 症见肌肉或关节红肿热痛、有沉重感, 步履艰难, 发热, 口渴不欲饮, 小便黄淡。功能主治: 祛风除湿, 清热消肿, 通络定痛。临床应用: 联合 csDMARDs 等常规药物或单独应用。改善结局: 有效率、晨僵时间、关节疼痛数、关节肿胀数、关节功能、双手握力。

新痹片^[73] (证据级别: D, 推荐强度: 弱)。使用条件: 湿热痹阻证、热毒瘀血甚者。功能主治: 清热解毒, 活血化瘀, 消肿止痛。临床应用: 联合 csDMARDs 等常规药物。改善结局: VAS 评分、中医证候积分。

4) 扶正祛湿剂

益肾蠲痹丸^[64] (证据级别: C, 推荐强度: 弱)。使用条件: 肝肾不足证或痰瘀痹阻证, 症见关节疼痛、屈伸不利、肿大畸形, 伴见皮下结节、肌肉疼痛、瘦削或僵硬。功能主治: 温补肾阳, 益肾壮督, 搜风剔邪, 蠲痹通络。临床应用: 联合 csDMARDs 等常规药物。改善结局: ACR20、疼痛关节数、晨僵时间。

尪痹片/胶囊^[64] (证据级别: C, 推荐强度: 弱)。使用条件: 肝肾亏虚、寒湿痹阻证, 症见关节冷痛、触之不温、疼痛遇寒加重, 关节屈伸不利, 畏寒肢冷, 腰膝酸软。功能主治: 补肝肾, 强筋骨, 祛风湿, 通经络。临床应用: 联合甲氨蝶呤片。改善结局: DAS28 评分、ACR20/50、中医证候积分。

痹祺胶囊^[64] (证据级别: C, 推荐强度: 弱)。

使用条件：气虚血瘀证，症见气短乏力、面色不华、食少纳差。功能主治：益气养血，祛风除湿，活血止痛。临床应用：活动期患者可联合 csDMARDs 等常规药物，缓解期患者可单独应用。改善结局：疼痛关节数、肿胀关节数、晨僵时间。

骨龙胶囊^[74-75]（证据级别：C，推荐强度：弱）。使用条件：风寒痹阻、肝肾不足证，症见关节冷痛、屈伸不利，腰膝酸软，下肢无力。功能主治：散寒止痛，活血祛风，强筋壮骨。临床应用：联合塞来昔布或 csDMARDs 等常规药物。改善结局：DAS28 评分、ACR20、中医证候疗效。

4.7 临床问题 7：RA 中医外治疗法的有效性与安全性如何？

推荐意见 9：可采用外治方法配合药物口服内外合治，在提高有效率的同时可有效改善关节疼痛、晨僵、活动度等局部症状。

1) 穴位贴敷^[76-77]（证据级别：B，推荐强度：强）。取穴：足三里、大椎、命门、关元、肾俞、外关、阳陵泉、膈俞、阿是穴、肺俞、昆仑、曲池；贴敷药物：细辛、乳香、没药、川乌、甘遂、白芥子、麝香、红花等。每周 1~3 次，根据病情酌情选择疗程。改善结局：VAS 评分、关节压痛数、关节肿胀数、晨僵时间、HAQ-DI 评分。

2) 三伏贴^[78]（证据级别：D，推荐强度：强）。取穴：大椎、丰隆、曲池、阴陵泉、阿是穴及经络循行路线；贴敷药物：细辛、白芥子、透骨草、甘遂、吴茱萸、麝香、洋金花等。贴敷时间在每年夏季初、中、末伏的第 1 天各贴药 1 次，每次贴敷 4~6 h，共 3 次。改善结局：关节疼痛、关节压痛、关节肿胀、晨僵时间、活动障碍及整体功能。

3) 三九贴敷^[79]（证据级别：D，推荐强度：弱）。取穴：足三里、肾俞、肝俞、命门、关元、阿是穴；贴敷药物：白芥子、延胡索、甘遂、细辛、肉桂、丁香等。贴敷时间为每年农历的冬至、一九、二九、三九，根据病情酌情选择疗程。改善结局：DAS28 评分、HAQ-DI 评分、VAS 评分、疾病复发率。

4) 春秋分穴位贴敷^[80]（证据级别：D，推荐强度：弱）。取穴：大椎、命门、腰阳关、内关、足三里、肺俞；贴敷药物：青风藤、透骨草、桑枝、狗脊、杜仲、补骨脂、白芥子、当归、姜黄、白芍、红花、三棱、胆南星、莪术、麝香、姜汁等。贴敷时间为每年春分或秋分当日开始贴敷，每

次贴敷 2~4h，隔 5 天贴敷 1 次，春分、秋分各贴敷 3 次，连续贴敷 2 年。改善结局：ACR20/50/70、HAQ-DI 评分、中医证候积分、年发病次数、发病次平均病程。

5) 中药外敷：(1) 复方雷公藤外敷剂^[81]（证据级别：C，推荐强度：弱）。药物成分主要为雷公藤、芒硝、川芎、炙乳香、炙没药。将药物涂抹到肿痛关节处，按摩至完全吸收，每日 1 次，疗程 8 周。改善结局：DAS28 评分、VAS 评分。(2) 金黄膏^[82-83]（证据级别：C，推荐强度：弱）。出自《医宗金鉴》，药物成分大黄、黄柏、苍术、川厚朴、姜黄、白芷、天南星、陈皮、天花粉、甘草。将金黄膏均匀涂抹在纱布上，用纱布置于患肢关节处皮肤上，可配合红外线局部照射治疗，治疗仪与皮肤间距离 30~40 cm，每次 20 min，温度以患部感觉温热为宜。每日 1 次，7 天为 1 个疗程，共 2 个疗程。改善结局：VAS 评分、晨僵时间、HAQ-DI 评分。

6) 穴位注射疗法^[84-85]（证据级别：D，推荐强度：弱）。取穴：外关、足三里、阳陵泉、三阴交、阿是穴。注射药物：鹿瓜多肽注射液、灯盏细辛注射液等。每次注射 2~4 个穴位，针刺得气并回抽无血即注入药物，每穴注射 1 ml，每周 3~5 次，根据药物与病情酌情调整剂量与频次，3~4 周为 1 个疗程。改善结局：有效率、中医证候积分。

7) 中药离子导入^[86-92]（证据级别：B，推荐强度：强）。中药离子导入既可将中药有效成分直接作用于膝关节，也可通过直流电刺激穴位。使用无菌纱布垫浸透药液（中药水煎剂、通络灵酊剂、正清风痛宁注射液等）后外敷于膝关节，低频治疗一般选择 10~20 级，以患者有微微麻胀感且可耐受为宜，每次治疗时间为 20~30 min，导入后进行 15 min 的局部按摩，每日 1 次，7~10 天为 1 个疗程，治疗 3 个疗程，两个疗程之间休息 3~5 天。改善结局：DAS28 评分、中医证候积分、VAS 评分、HAQ-DI 评分、关节压痛数、关节肿胀数、晨僵时间。

8) 中药泡洗或熏蒸法^[93]（证据级别：C，推荐强度：弱）。(1) 寒湿痹证^[94]：草乌、附子、伸筋草、铁线莲、当归、红花、白头翁、肉桂、艾叶、刺五加、小茴香、陈皮、柴胡、田七等。(2) 四肢熏蒸^[95]：可选用羌活、独活、防风、桂枝、细辛、川芎、海风藤、徐长卿、姜黄、苏木、冰片等，治以祛风除湿、温经散寒、活血通络；(3) 颈肩腰背熏蒸^[95]：可选用羌活、独活、桂枝、川乌、

草乌、姜黄、千年健、威灵仙、杜仲、续断、牛膝、冰片等，治以温补肾阳、强壮筋骨为主。蒸汽温度设置在 55℃ 左右，淋洗的药液在 48℃ 左右时即可治疗，每次 30~40 min，每日 1 或 2 次，3 周为 1 个疗程。改善结局：VAS 评分、关节活动度、晨僵时间、关节局部温度、HAQ-DI 评分。

9) 中药蜡疗^[96] (证据级别：B，推荐强度：弱)。中药蜡疗是将中药外敷与蜡疗技术相结合的一种中医外治法，具有药疗和热疗双重作用，蜡疗的持久温热和压迫作用可增加中药的经皮渗透吸收，可起到消炎止痛、活血化瘀、温经通络之效。治疗 20 min 后取下蜡饼，中药膏贴敷可留置 6~8 h。2 周为 1 个疗程。改善结局：DAS28 评分、VAS 评分。

10) 针灸^[97] (证据级别：B，推荐强度：弱)。根据患者主要累及关节辨证选穴，如足三里、阳陵泉、三阴交、外关、解溪、阳池及关元等；穴位常规消毒后以单手进针法进针，采用提插补法、平补平泻法针刺穴位。以穴位调节针刺深度，每日 1 次。改善结局：VAS 评分、关节压痛数、关节肿胀数、晨僵时间、HAQ-DI 评分。

11) 针刀^[98] (证据级别：B，推荐强度：弱)。通过松解粘连以及肿胀关节的关节囊，达到排出渗出液、减轻病变关节压力的目的，使患者关节部位的疼痛得到有效缓解，利于关节活动。根据关节结构，治疗点选取以压痛点及韧带起止点为主，每次选 6~8 个部位，可配合手法松解。改善结局：有效率、VAS 评分、晨僵时间。根据患者病情，亦可选择微创针刀镜进行治疗^[99]，改善结局：DAS28 评分、VAS 评分、关节压痛数、关节肿胀数、晨僵时间、Lysholm 膝关节评分。

12) 推拿手法^[100] (证据级别：D，推荐强度：弱)。根据患者主要累及关节的具体情况，对特定腧穴、阿是穴采取推揉点按、拔伸摇转、拿捏弹拨等多种理筋、正骨推拿手法，以期达到疏通经络、行气止痛、祛邪扶正的疗效。治疗以患者可忍受为度，幅度逐渐增加，循序渐进，适可而止，可先被动运动再主动运动，每次 20~30 min，每日 1 次。2~4 周为 1 个疗程。改善结局：有效率、VAS 评分、晨僵时间、髌上囊滑膜厚度。

4.8 临床问题 8：中医药如何治疗 RA 的合并症 (脏腑损伤)?

推荐意见 10：RA 常合并脏腑损伤，呈现“体脏合痹”的临床特点，建议遵循“以体养脏、调脏

安体、体脏同治”的治疗理念。(共识意见)

RA 可以造成多系统、多脏器损害，常见的关节外并发症包括心血管疾病、肺部疾病，呈现肢体与脏腑同病的复杂特性，疾病模式由单一向多元演变。遵循中医整体观念辨证思维，以五行、气血津液及脏腑经络理论为基础，立足“五体痹”“五脏痹”传变与风湿免疫病转归特点的“体脏合痹”学说^[101]，有助于 RA 脏腑损伤合并症的系统化防治。

肺部受累为 RA 常见并发症，肺间质病变 (ILD) 表现为肺实质进行性纤维化和肺功能变化。研究显示，补肺活血化痰类中药汤剂联合常规西药治疗 RA-ILD 可改善患者疾病活动度及肺功能指标用力肺活量 (FVC)、肺高分辨率 CT (HRCT) 半定量积分^[102-104]；雷公藤多苷片联用西医常规治疗 RA-ILD 可改善 ACR50 达标率、HRCT 定量评分、肺功能参数评分及生活质量^[105-108]。

RA 患者因炎症状态、自身免疫改变、血管内皮功能紊乱及相关治疗药物的使用，其合并心血管疾病 (CVD) 的危险性增加^[109-110]，是 RA 主要的死亡原因，平均寿命缩短 5~10 年^[111]。临床治疗常从活血化瘀、祛风除痹之法着手，根据标本缓急分期论治，辨证选择理气、化痰、活血、利水以治标，益气、补心、养阴、温阳以固本，共奏祛风湿、除心痹之效。

4.9 临床问题 9：中医药如何联合 DMARDs 治疗 RA?

推荐意见 11：明确诊断后应尽早开始中医药联合 csDMARD 治疗，推荐首选联合甲氨蝶呤，存在甲氨蝶呤禁忌时考虑联合其他 csDMARD。(共识意见)

推荐意见 12：中医药联合单一 csDMARD 治疗未达标时，建议更换或联合两种 csDMARD 进行治疗，或联合一种生物制剂改善病情抗风湿药物 (bDMARDs) 或/靶向合成改善病情抗风湿药物 (tsDMARD) 进行治疗。(共识意见)

推荐意见 13：对于疾病活动度高、预后差的患者，可在起始治疗时采用中医药联合 bDMARD/tsDMARD 治疗。(共识意见)

推荐意见 14：中医药的联合运用可适当减少 csDMARD/bDMARD/tsDMARD 的应用剂量，有利于长期维持治疗，减少感染等不良事件发生率。(共识意见)

EULAR 发布的 RA 治疗指南推荐^[14]：RA 一经

确诊,应于发病初期3~6个月内启用DMARDs,通过达标治疗严密控制病情,以达到缓解或低疾病活动。中西医结合疗法能有效地调节机体免疫功能,有效减轻患者疼痛的症状,改善疾病活动度,提高生活质量,且安全性良好^[112]。结合患者具体情况,尽早采用中医药联合DMARDs治疗,且中药适合长期维持治疗。

4.10 临床问题10:中医药治疗RA的安全性如何?

推荐意见15:中药治疗RA的安全性较高,在西医常规治疗基础上合理应用中医药治疗,不会增加不良事件,甚至可发挥减毒功效。(共识意见)

一项Meta分析显示,中药治疗(桂枝芍药知母汤)的不良反应发生率低于西药(甲氨蝶呤片)^[30]。另一项随机对照试验(RCT)比较中药治疗(清热活血方+清热化瘀凝胶)、西药治疗(甲氨蝶呤片+羟氯喹)、中西药联合治疗(清热活血方+清热化瘀凝胶+甲氨蝶呤片+羟氯喹)的结果显示,中药治疗的不良事件发生率最低,西药治疗和中西药联合治疗的不良事件发生率相对较高^[34]。另有RCT表明中西医结合治疗不良反应发生率低于单纯西医治疗^[113-114]。

4.11 临床问题11:RA患者病情评估要点有哪些?

推荐意见16:对RA初始治疗或治疗未达标者,建议疾病活动度监测频率为每月1次;对治疗已达标者,监测频率为每3~6个月1次。(共识意见)

推荐意见17:治疗全程应重视药物安全性监测,关注患者心肺变化及感染等,建议每3个月行血常规、尿常规、肝功能、肾功能检查;治疗方案调整后,应及时进行安全性监测;应用药性峻猛、毒副作用较强的中药时,需注意合理配伍及剂量,密切监测不良反应。(共识意见)

推荐意见18:建议采用中国类风湿关节炎患者报告的疾病活动度指数(CPRI-RA)、HAQ-DI或健康调查简表(SF36)量表等基于患者的报告结局与临床客观指标进行互补,全面评价RA病情变化及治疗效果。(共识意见)

CPRI-RA^[115]是中华中医药学会风湿病分会制定的适合于我国国情、符合本土文化的RA患者报告的临床结局(PRO)量表,其从患者报告的角度出发,较传统的医生报告的结局测量方法在RA药物疗效评估、疾病监测、慢病管理等方面更能彰显优势。

HAQ-DI评分^[116]作为ACR推荐的特异性量表,在RA的临床研究中被广泛用于评估患者的躯体功能。

SF-36量表^[117]是一种普适性健康相关生活质量量表,共8个维度有36个条目,可用于不同疾病和条件的人群,其信度和效度已经得到广泛的验证,在RA的临床研究中已得到了普遍应用。

4.12 临床问题12:RA患者慢病管理的要点有哪些?

推荐意见19:RA患者治疗达标6个月后,可考虑逐渐减量,减量过程中需严密监测,谨防复发;临床缓解患者,不建议完全停药,如若停药应定期监测评估。(共识意见)

达标治疗可有效缓解症状和控制病情^[118],RA达到临床缓解或低疾病活动度时应维持长期治疗。研究显示,与达到临床缓解后不停用药物者相比,完全停用药物的患者疾病复发率增加,且50%的患者难以恢复到复发前的生理状态^[119-121];RA患者的用药依从率为58%~75%,且会随着用药时间的延长而下降^[121];用药依从性较差会严重影响患者的治疗效果和预后,促进RA患者长期服药信念向行为的转变十分重要^[122]。患者达到临床缓解后应在临床医师的指导下逐步减少药物剂量,如患者治疗方案为联合治疗,可先减少其中一种药物的剂量。在撤减药物期间应对患者进行严密监测,根据患者具体情况1~3个月复查1次,评估患者疾病活动。

推荐意见20:良好的医患沟通和患者教育是临床疗效的保障。医-护-患一体化慢病管理模式可提高患者对疾病的认识,增加对治疗方案的了解,提升用药依从性,解除心理负担,树立战胜疾病的信心,取得良好的预后。(共识意见)

研究表明,患者对疾病的认知程度与其预后呈正相关^[123];临床实践中应向患者提供以需求为导向的健康教育^[124],同时争取患者家属的配合与协助,营造和谐的治疗环境,恢复患者失调的心理,促进病情好转^[125];医生与患者共同决策的过程有利于提高患者依从性,获得更好的预后,提高对治疗的满意度^[126]。

创新慢病管理的模式,加强医护患合作意识,为患者制定包含心理疏导、疾病宣教、用药干预、功能锻炼、饮食指导的多维度护理措施,可改善患者的身心健康,提高生活质量与舒适度^[127-128];借助电话、公众号、数据库等构建多媒体管理模式有助于提高患者依从性,实现定期规律随访,有助于基层医院类风湿关节炎患者健康行为能力的提升。

推荐意见21:患者生活调摄应遵循未病先防、既病防变、瘥后防复的原则,顺应四时节气正确指导患者生活起居、饮食宜忌、中药药膳等,提高机

体的抗病能力, 延缓疾病的进展。(共识意见)

推荐意见 22: 传统功法可减轻 RA 造成的关节僵硬、肌肉萎缩、骨质疏松, 有助于保持关节功能、改善情志, 进而提高生活质量。

RA 患者在日常生活中, 应注意避风寒湿, 居住地应干燥、温暖、向阳, 同时注意保暖, 多晒太阳, 预防感冒^[18]。RA 患者应注意生活方式的调整, 肥胖和吸烟不仅增加 RA 的发病率, 也会加重 RA 的病情^[129-130]。合理饮食有助于 RA 患者的病情控制^[131], 具体要根据患者情况进行个体化饮食指导。

1) 中药药膳。国医大师路志正先生提出健脾和胃“三阶梯”方案^[132]应贯穿风湿病治疗始终: 第一阶梯“治未病”, 常选用谷芽、麦芽、炒神曲、生姜、甘草, 以和中开胃; 第二阶梯“健脾消食”, 常选促进药物吸收的药物, 如炒山楂、炒麦芽、炒神曲、鸡内金、莲子肉、炒扁豆; 第三阶梯“全程顾护脾胃、扶正御邪”, 常选白术、山药、茯苓、炒薏苡仁等。脾胃功能虚弱、胃纳不佳者, 首先要进行脾胃功能的调理, 进行分段饮食, 早期进食山药、粥类等健脾胃之品, 后期胃纳改善, 可辨证选择药膳调理。食材方面, 苦瓜、芹菜、白菜、丝瓜、冬瓜、薏苡仁等食物具有清热解暑或利水消肿的作用, 有助于缓解患者关节肿胀、发热、疼痛等症状, 可适当食用; 人参、鹿茸等温阳之品不宜服食, 羊肉等温热发性食物亦应少食, 热性水果也不可多食, 肥腻食物、油炸食品、甜食等应尽量少食用或不食用, 以免助生湿热加重病情。另外, RA 患者可伴有不同程度的贫血和骨质疏松, 因此不提倡全素饮食, 应适量食用瘦肉、鸡蛋、牛奶、豆制品等富含铁剂或钙剂的食物。

2) 传统功法。传统功法以人体生命整体观作为理论基础, 通过调身、调心、调息相配合, 体现出形、气、神三位一体生命观。研究显示, 太极拳^[133](证据级别: B, 推荐强度: 强)可改善 RA 患者 ACR20、HAQ-DI 评分、情绪、抑郁和功能指数; 八段锦^[134](证据级别: D, 推荐强度: 弱)可改善 VAS 评分、SF-36; 易筋经^[135](证据级别: D, 推荐强度: 弱)可改善晨僵时间、关节肿胀指数、关节疼痛指数、双手平均压力、ESR 及 CRP。在 RA 疾病活动期, 关节肿痛明显, 此时不建议锻炼, 以免病情加重; 疾病稳定期逐渐加强肢体功能锻炼。

利益冲突声明和其他说明

本指南项目组成员在项目正式启动前均签署了“利益冲突声明书”, 声明无利益冲突。在指南制定过程中, 所有相关参与者均无利益冲突。

指南负责起草单位: 中国中医科学院广安门医院

指导委员会: 姜泉 (中国中医科学院广安门医院)、刘健 (安徽中医药大学第一附属医院)、何东仪 (上海市光华中西医结合医院)、唐晓颇 (中国中医科学院广安门医院)、巩勋 (中国中医科学院广安门医院)、方勇飞 (重庆大学附属人民医院)、刘英 (山东中医药大学附属医院)、刘维 (天津中医药大学第一附属医院)、李振彬 (白求恩国际和平医院)、张剑勇 (深圳市中医院)、黄清春 (广东省中医院)、彭江云 (云南中医药大学第一附属医院)、陈薇 (北京中医药大学循证医学中心)

共识专家组 (按姓氏笔画排序): 于静 (辽宁中医药大学附属医院)、马武开 (贵州中医药大学第二附属医院)、王莘智 (湖南中医药大学第一附属医院)、王海东 (甘肃省中医院)、刘品莉 (山西省中医院)、齐岩 (北京同仁堂中医医院)、纪伟 (江苏省中医院)、苏晓 (上海市中医医院)、李琴 (青海省中医院)、李延萍 (重庆市中医院)、李泽光 (黑龙江中医药大学附属第一医院)、吴金玉 (广西中医药大学第一附属医院)、宋欣伟 (浙江省中医院)、张华东 (中国中医科学院广安门医院)、张俊莉 (西安市第五医院)、张海波 (长春恒康中医医院)、周祖山 (湖北省洪湖市中医院)、庞学丰 (广西中医药大学附属瑞康医院)、郑福增 (河南省中医院)、赵凯 (宁夏医科大学)、赵钟文 (福建中医药大学附属第二人民医院)、姜萍 (山东省中医院)、姜玉铃 (河南风湿病医院)、郭刚 (河北以岭医院)、陶庆文 (中日友好医院)、曹炜 (中国中医科学院望京医院)、梁翼 (四川省骨科医院)、董秋梅 (内蒙古医科大学)、喻建平 (江西中医药大学附属医院)、曾翠青 (海南省中医院)、温成平 (浙江中医药大学)、照日格图 (新疆维吾尔自治区中医院)、薛鸾 (上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院)。

执笔人: 姜泉[✉]、巩勋、焦娟、宋梦歌、韩曼、张柔曼、周新尧

✉ 通讯作者: doctorjq@126.com

参考文献

- [1] 姜泉. 实用中医风湿免疫病学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2022: 311.
- [2] 中华中医药学会风湿病分会. 类风湿关节炎病证结合诊疗指南[J]. 中医杂志, 2018, 59(20): 1794-1800.
- [3] BROZEK JL, AKL EA, ALONSO-COELLO P, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations in clinical practice guidelines. Part 1 of 3. An overview of the GRADE approach and grading quality of evidence about interventions[J]. Allergy, 2009, 64(5): 669-677.
- [4] 国家卫生健康委员会. 国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11) 中文版[EB/OL]. (2018-12-14) [2025-05-01]. <http://www.nhpc.gov.cn/zyygj/s7659/201812/14caf755107c43d2881905a8d4f44ed2.shtml>.
- [5] AMETT FC, EDWORTHY SM, BLOCK DA, et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis[J]. Arthritis Rheum, 1988, 31(3): 315-324.
- [6] ALETAHA D, NEOGI T, SILMAN AJ, et al. Arthritis-Rheum. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative[J]. Ann Rheum Dis, 2010, 69(9): 1580-1588.
- [7] SAFIRI S, KOLAH AA, HOY D, et al. Global, regional and national burden of rheumatoid arthritis 1990-2017: a systematic analysis of the global burden of disease study 2017[J]. Ann Rheum Dis, 2019, 78(11): 1463-1471.
- [8] LI R, SUN J, REN LM, et al. Epidemiology of eight common rheumatic diseases in China: a large-scale cross-sectional survey in Beijing[J]. Rheumatology (Oxford), 2012, 51(4): 721-729.
- [9] JIN S, LI M, FANG Y, et al. Chinese registry of rheumatoid arthritis (CREDIT): II. Prevalence and risk factors of major comorbidities in Chinese patients with rheumatoid arthritis[J]. Arthritis Res Ther, 2017, 19(1): 251.
- [10] 周云杉, 王秀茹, 安媛, 等. 全国多中心类风湿关节炎患者残疾及功能受限情况的调查[J]. 中华风湿病学杂志, 2013, 17(8): 526-532.
- [11] VAN DEN HOEK J, BOSHUIZEN HC, ROORDA LD, et al. Mortality in patients with rheumatoid arthritis: a 15-year prospective cohort study[J]. Rheumatol Int, 2017, 37(4): 487-493.
- [12] GORDON P, WEST J, JONES H, et al. A 10 year prospective followup of patients with rheumatoid arthritis 1986-1996[J]. J Rheumatol, 2001, 28(11): 2409-2415.
- [13] GABRIEL SE, CROWSON CS, O'FALLON WM. Mortality in rheumatoid arthritis: have we made an impact in 4 decades?[J]. Rheumatol, 1999, 26(12): 2529-2533.
- [14] SMOLEN JS, LANDEWÉ RBM, BERGSTRÄ SA, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2022 update[J]. Ann Rheum Dis, 2023, 82(1): 3-18.
- [15] GILES JT. Extra-articular manifestations and comorbidity in rheumatoid arthritis: potential impact of pre-rheumatoid arthritis prevention[J]. Clin Ther, 2019, 41(7): 1246-1255.
- [16] DI MATTEO A, BATHON JM, EMERY P. Rheumatoid arthritis[J]. Lancet, 2023, 402(10416): 2019-2033.
- [17] SANTOS EJF, DUARTE C, FERREIRA RJO, et al. Determinants of happiness and quality of life in patients with rheumatoid arthritis: a structural equation modelling approach[J]. Ann Rheum Dis, 2018, 77(8): 1118-1124.
- [18] 王承德, 沈丕安, 胡荫奇. 实用中医风湿病学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 501.
- [19] 周新尧, 韩曼, 肖红, 等. 病证结合、分期论治类风湿关节炎[J]. 北京中医药, 2019, 38(10): 1020-1023.
- [20] 刘蔚翔, 姜泉. 类风湿关节炎“湿、热、瘀”病机理论探析[J]. 中医杂志, 2020, 61(24): 2148-2153.
- [21] 郭蕾, 王永炎, 张志斌. 关于证候概念的诠释[J]. 北京中医药大学学报, 2003, 26(2): 5-8.
- [22] 巩勋, 崔家康, 姜泉, 等. 1388 例类风湿关节炎患者中医证型与疾病活动度特征横断面调查[J]. 中医杂志, 2021, 62(4): 312-317.
- [23] 张春雷, 李冀. 蠲痹汤加减治疗风湿痹阻型类风湿关节炎的临床疗效[J]. 中医药学报, 2022, 50(2): 68-71.
- [24] 顾向浩, 陈鹏, 朱琳, 等. 蠲痹汤辅助治疗类风湿关节炎活动期的疗效观察[J]. 中国中西医结合杂志, 2021, 41(7): 812-816.
- [25] 马秀琴, 任静静, 刘加昌. 蠲痹汤联合甲氨蝶呤对类风湿关节炎患者血清相关因子及骨代谢的影响[J]. 世界中西医结合杂志, 2019, 14(1): 122-125.
- [26] 李建, 荣兵, 贾峻, 等. 蠲痹汤加减对风寒湿痹型类风湿关节炎患者关节液中炎症因子, 血清 MMP-3, OPG 及 RANKL 的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(22): 165-170.
- [27] 王蓉辉, 陈运春, 王伟丽, 等. 蠲痹汤加减联合甲氨蝶呤及来氟米特治疗活动期类风湿性关节炎寒湿痹阻证临床观察[J]. 中国实验方剂学杂志, 2016, 22(6): 167-171.
- [28] 孙翠英, 刘建玲, 顾文. 大秦艽汤治疗类风湿关节炎临床研究[J]. 新中医, 2019, 51(9): 87-89.
- [29] 兰维娅, 唐芳, 马武开, 等. 乌头汤联合常规西药治疗类风湿关节炎随机对照试验的 Meta 分析[J]. 风湿病与关节炎, 2019, 8(1): 36-40, 45.
- [30] 李萍, 王银洁. 桂枝芍药知母汤治疗类风湿关节炎的 Meta 分析[J]. 上海中医药杂志, 2019, 53(2): 14-19.

- [31]董龙聪,邓路达,兰维娅,等. 桂枝芍药知母汤联合常规西药对类风湿关节炎疗效的 Meta 分析[J]. 风湿病与关节炎,2018,7(11):25-31.
- [32]崔家康,陈晓,高青杰,等. 宣痹汤联合化学药物治疗类风湿关节炎有效性和安全性的 meta 分析[J]. 中医研究,2022,35(9):59-63.
- [33]胡茹英,刘效栓,刘军刚,等. 当归拈痛汤治疗湿热痹阻型类风湿关节炎的 Meta 分析[J]. 甘肃医药,2021,40(2):133-138.
- [34]ZHANG R, TANG XP, WANG J, et al. The impact of traditional Chinese medicine Qingre Huoxue treatment and the combination of methotrexate and hydroxychloroquine on the radiological progression of active rheumatoid arthritis: a 52-week follow-up of a randomized controlled clinical study [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2022:5808400. doi:10.1155/2022/5808400.
- [35]GONG X, LIU WX, TANG XP, et al. Traditional Chinese medicine Qingre Huoxue treatment vs. the combination of methotrexate and hydroxychloroquine for active rheumatoid arthritis: a multicenter, double-blind, randomized controlled trial[J]. Front Pharmacol, 2021, 12:679588. doi:10.3389/fphar.2021.679588.
- [36]杜羽,王雷,罗成贵,等. 清热活血方药治疗类风湿关节炎 3 年期放射学评价研究[J]. 世界中西医结合杂志,2018,13(11):1577-1580.
- [37]CHAE SY, WOO Y, KIM JH, et al. The effectiveness and safety of Simiao Xiaobi decoction on rheumatoid arthritis: a study protocol for systematic review and meta-analysis [J]. Medicine (Baltimore), 2022, 101 (12) : e29174.
- [38]范为民,李艳. 清络饮加味治疗类风湿性关节炎临床观察[J]. 实用中医药杂志,2016,32(2):108-109.
- [39]张翠霞,尹谢添,梅应兵,等. 双合汤治疗类风湿关节炎急性发作期(痰瘀痹阻证)的临床疗效[J]. 中国中医急症,2021,30(7):1237-1240.
- [40]王红,刘振华,刘小静,等. 双合汤联合甲氨蝶呤治疗痰瘀痹阻证类风湿关节炎临床疗效观察[J]. 现代中药研究与实践,2023,37(4):85-88.
- [41]李德亮,史成,齐岩,等. 双合汤治疗类风湿性关节炎急性发作期的临床效果研究[J]. 现代诊断与治疗,2023,34(17):2548-2550.
- [42]沈世英,陈洋,刘静利,等. 加味身痛逐瘀汤联合甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎临床研究 [J]. 实用中医药杂志,2022,38(1):93-94.
- [43]周金彬,谢美芳,单华. 身痛逐瘀汤联合西药治疗类风湿关节炎瘀血痹阻证的临床疗效观察[J]. 中西医结合心血管病电子杂志,2020,8(5):164.
- [44]王佳,王钢,王涛,等. 身痛逐瘀汤联合西药治疗类风湿关节炎瘀血痹阻证的临床观察 [J]. 中国实验方剂学杂志,2017,23(24):185-189.
- [45]田敏,帅云飞,李鑫. 黄芪桂枝五物汤联合化学药物治疗类风湿性关节炎临床疗效及安全性 Meta 分析[J]. 中国免疫学杂志,2021,37(16):1964-1966.
- [46]石欣,胡红,陈君. 归脾汤加味联合来氟米特治疗类风湿关节炎疗效观察[J]. 中医临床研究,2020,12(14):90-93.
- [47]王丹,张薇,鲍蕴琦,等. 归脾汤加减治疗气血两虚型类风湿关节炎伴抑郁症的临床效果[J]. 临床医学研究与实践,2021,6(30):112-114,118.
- [48]张黄鑫,王楚函,朱朝霞,等. 独活寄生汤联合常规西药治疗类风湿关节炎疗效的 Meta 分析[J]. 风湿病与关节炎,2019,8(9):28-35.
- [49]何龙,李素美. 独活寄生汤辨证加减治疗类风湿关节炎的有效性以及对患者免疫功能的影响[J]. 中国医学创新,2021,18(26):96-100.
- [50]纪德凤,张春芳. 三痹汤治疗类风湿关节炎的 Meta 分析[J]. 亚太传统医药,2016,12(14):80-83.
- [51]李玲. 三痹汤配合西药治疗类风湿关节炎临床研究 [J]. 河南中医,2021,41(12):1874-1877.
- [52]何春晓,陈光耀,徐愿,等. 补肾祛寒治痿汤联合甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎系统综述[J]. 世界中西医结合杂志,2018,13(12):1643-1647.
- [53]王钢,王涛,党鹏. 补肾祛寒治痿汤联合甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎 30 例临床观察[J]. 中国中医基础医学杂志,2021,27(8):1298-1300.
- [54]姚传辉,徐才钦,张雨樵,等. 补肾治痿汤延缓类风湿关节炎骨侵蚀进展的临床观察[J]. 中国中医基础医学杂志,2023,29(6):976-981.
- [55]兰天仪,王子涵,鄢泽然,等. 基于改良 Sharp 评分观察补肾治痿汤对类风湿关节炎肝肾不足证骨破坏的延缓作用[J]. 北京中医药大学学报,2023,46(4):557-563.
- [56]李爱峰,李赛. 四神煎加味治疗活动期类风湿性关节炎疗效观察[J]. 广西中医学院学报,2010,13(2):33-34.
- [57]张博轮,高明利,于静,等. 益气养阴通络方治疗气阴两虚型类风湿关节炎的临床疗效与安全性观察[J]. 时珍国医国药,2022,33(11):2695-2698.
- [58]文建庭,刘健,孙艳秋,等. 新风胶囊治疗类风湿关节炎 Meta 分析[J]. 安徽中医药大学学报,2020,39(5):83-88.
- [59]朱子衡,万磊,刘健,等. 基于 Apriori 关联规则和随机行走模型研究复方雷公藤制剂(新风胶囊)改善类风湿关节炎脾虚湿盛证免疫炎症的临床疗效[J]. 中国实验方剂学杂志,2023,29(5):32-38.
- [60]彭海聪,邱明山,赵银龙,等. 参芪五藤汤配合来氟米特治疗气虚络阻证类风湿关节炎的效果及对关节功能、血清 RF 和 ESR 水平的影响[J]. 中国药物滥用防治杂志,2023,29(12):2231-2235.

- [61] 惠晓艳, 张芳, 王晨, 等. 黄芪五藤汤联合甲氨蝶呤片治疗类风湿关节炎气虚络阻证的临床疗效[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(8): 4877-4880.
- [62] 章建华, 成立, 王维佳, 等. 五藤汤治疗类风湿性关节炎的临床研究[J]. 中国中医骨伤科杂志, 2007, 15(1): 20-21, 71.
- [63] 王素梅, 王熙, 龚芹. 中西医结合治疗类风湿关节炎 40 例观察[J]. 四川中医, 2006, 24(6): 47-48.
- [64] 《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目组. 中成药治疗类风湿关节炎临床应用指南(2022 年)[J]. 中国中西医结合杂志, 2023, 43(3): 261-273.
- [65] 谢子葳, 谢碧岑, 帅云飞, 等. 白芍总苷联合甲氨蝶呤片与来氟米特治疗类风湿关节炎疗效和安全性 Meta 分析[J]. 中国免疫学杂志, 2022, 38(3): 370-378.
- [66] 杜天信, 任汉阳, 李根林. 寒湿痹片治疗寒湿痹阻型风湿病的临床观察[J]. 中医正骨, 2002, 14(8): 453-455, 511.
- [67] 陈辉, 刘伟杰, 李伟. 盘龙七片辅助甲氨蝶呤片和美洛昔康治疗类风湿关节炎的疗效及对 TLR/MyD88 信号通路的影响[J]. 中国医院用药评价与分析, 2023, 23(3): 290-294.
- [68] 李婷, 郑宝林, 叶美杏, 等. 通痹胶囊治疗类风湿关节炎的疗效及对微循环和血清 MMP-1、MMP-3 的影响[J]. 现代生物医学进展, 2020, 20(16): 3117-3120.
- [69] 何晓红, 史玉媛, 周晓莉, 等. 通络开痹片治疗关节炎(类风湿关节炎、膝骨关节炎)疗效及安全性的真实世界研究[J]. 中草药, 2023, 54(17): 5657-5664.
- [70] 宋梦歌, 姜泉, 焦娟, 等. 罗浮山风湿膏药治疗类风湿关节炎腕关节炎的多中心随机双盲对照临床研究[J]. 北京中医药大学学报, 2023, 46(10): 1431-1442.
- [71] 王海东, 年芳红, 金芳梅. 祖师麻膏药治疗寒湿痹阻型类风湿关节炎腕关节病变 40 例[J]. 西部中医药, 2016, 29(10): 107-109.
- [72] 王晶, 张万明, 罗艳华. 湿热痹冲剂治疗类风湿关节炎 46 例[J]. 中国地方病防治杂志, 2012, 27(4): 313-314.
- [73] 杨国琴, 吴芸, 康佳莹, 等. 新痹片外用联合督灸治疗类风湿关节炎效果观察[J]. 世界临床药物, 2022, 43(2): 169-173.
- [74] 唐晓娟, 姜泉, 刘英, 等. 骨龙胶囊联合抗风湿药治疗类风湿关节炎的临床观察[J]. 中国新药杂志, 2020, 29(8): 895-902.
- [75] 任少琳, 彭磊, 蒋翠芸. 骨龙胶囊联合塞来昔布治疗类风湿性关节炎的临床研究[J]. 现代药物与临床, 2019, 34(8): 2468-2472.
- [76] 王锐, 刘宇轩, 李永吉, 等. 穴位贴敷疗法治疗类风湿性关节炎疗效及安全性 Meta 分析[J]. 中医药学报, 2020, 48(4): 39-46.
- [77] 郭亚丽, 李海婷, 贾伞伞, 等. 穴位贴敷疗法治疗类风湿性关节炎疗效的 Meta 分析[J]. 中西医结合护理, 2021, 7(1): 50-55.
- [78] 赵兴奎, 尹楠, 高花荣. 三伏贴治疗类风湿性关节炎的临床研究[J]. 中华中医药杂志, 2010, 25(10): 1714-1716.
- [79] 贾蝉忆, 谢华灵. 三九穴位贴敷减少类风湿关节炎复发临床疗效观察[J]. 中国疗养医学, 2023, 32(8): 844-847.
- [80] 姜兆荣, 莫成荣, 王玲, 等. 春秋分穴位贴敷疗法治疗寒湿痹阻型类风湿关节炎患者随机、盲法、安慰剂对照研究[J]. 辽宁中医药大学学报, 2023, 25(9): 8-12.
- [81] 焦娟, 唐晓娟, 员晶, 等. 复方雷公藤外敷剂对类风湿关节炎患者关节疼痛的影响[J]. 中国中西医结合杂志, 2016, 36(1): 29-34.
- [82] 范萍, 李国陵, 郭玲妹. 金黄膏外敷联合红外线对类风湿关节炎患者的疗效[J]. 上海护理, 2014, 14(1): 36-38.
- [83] 王薇萍, 史生铭, 刘欢, 等. 外敷金黄膏结合常规治疗湿热痹阻型类风湿关节炎临床观察[J]. 上海中医药杂志, 2007, 41(6): 47-48.
- [84] 康朝宾, 赵亚妮, 卢延荣. 温针灸联合灯盏细辛穴位注射治疗类风湿性关节炎临床研究[J]. 现代中医药, 2022, 42(6): 117-121.
- [85] 杨丹, 姚丽红, 张冰. 鹿瓜多肽穴位注射联合来氟米特、温针灸治疗类风湿关节炎[J]. 实用中西医结合临床, 2020, 20(13): 10-11, 67.
- [86] 李明, 尚双双, 万磊, 等. 清热除痹方离子导入在活动期类风湿关节炎患者达标治疗中的应用[J]. 安徽中医药大学学报, 2023, 42(3): 13-18.
- [87] 姜楠, 王小龙, 陆永雷, 等. 祛寒通络方离子导入联合来氟米特与依托考昔治疗寒湿痹阻型类风湿关节炎疗效观察[J]. 医学理论与实践, 2023, 36(10): 1690-1692.
- [88] 刘天阳, 刘健, 黄传兵, 等. 清热通络方离子导入治疗湿热痹阻型类风湿关节炎疗效观察[J]. 辽宁中医杂志, 2019, 46(2): 318-321.
- [89] 马建辉, 刘博华, 王丽丽, 等. 通络灵酊剂中频导入对类风湿关节炎湿热证患者膝关节病变的影响[J]. 中成药, 2018, 40(7): 1490-1493.
- [90] 黄志敏, 唐宇, 吴金玉, 等. 中频导入正清风痛宁片注射液联合西药治疗类风湿性关节炎疗效观察[J]. 广西中医药, 2014, 37(6): 32-35.
- [91] 张攀科, 徐雪峰, 杨科朋, 等. 正清风痛宁片注射液离子导入治疗类风湿性关节炎[J]. 中国当代医药, 2012, 19(2): 106-107.
- [92] 钟丽, 万萍. 正清风痛宁注射液离子导入疗法改善类风湿关节炎疼痛程度疗效观察[J]. 中国中医急症, 2010, 19(10): 1690-1691, 1706.
- [93] 张俊鹏, 秦元梅, 田一川, 等. 中医外治法对类风湿性关节炎疗效的网状 Meta 分析[J]. 中医学报, 2023, 38

- (12):2697-2712.
- [94] DU YT, LIU L, NIU ZZ, et al. Efficacy of TCM fumigation using dampness-and-cold-dispelling formula combined with methotrexate and leflunomide treating rheumatoid arthritis with cold-dampness bi syndrome [J]. Clin Complement Med Pharmacol, 2024, 4(1):100126.
- [95] 陈志煌, 沈鹰, 刘明岭, 等. 中药熏蒸治疗活动期类风湿关节炎临床疗效观察[J]. 中国临床保健杂志, 2012, 15(2):113-116.
- [96] 张祥利, 陈谊月, 蒋玉琼. 中药蜡疗治疗类风湿关节炎临床疗效的 meta 分析[J]. 中国医药科学, 2022, 12(24):20-23, 99.
- [97] LU HL, CHANG CM, HSIEH PC, et al. The effects of acupuncture and related techniques on patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis [J]. Chin Med Assoc, 2022, 85(3):388-400.
- [98] 陈辉, 陈南萍, 马久力. 针刀联合药物治疗类风湿性关节炎疗效 Meta 分析[J]. 光明中医, 2024, 39(5):841-846.
- [99] 孙君阳, 李蒋凤, 张勇, 等. 微创针刀镜辅助治疗类风湿关节炎临床疗效的 Meta 分析[J]. 中医药导报, 2022, 28(12):211-219.
- [100] 聂智兴, 韩大鹏, 徐凯捷, 等. 中药熏蒸联合推拿手法治疗膝关节类风湿关节炎的临床疗效观察[J]. 医学综述, 2020, 26(7):1452-1456.
- [101] 姜泉. “体脏合痹”理论内涵及其在风湿免疫病防治中的应用思路[J]. 中医杂志, 2024, 65(16):1656-1661.
- [102] 姚静慧, 王运超, 赵哲虹, 等. 清肺化痰方联合吡非尼酮治疗肺热血瘀型类风湿关节炎相关进行性纤维化表型间质性肺病的临床疗效[J]. 上海中医药杂志, 2022, 56(9):58-63.
- [103] 王超群, 金朝晖. 补肺化痰汤联合吡非尼酮治疗类风湿关节炎相关肺间质病变 30 例[J]. 湖南中医杂志, 2020, 36(5):49-51.
- [104] 王慧莲, 李松伟, 王济华, 等. 益气养阴通痹方治疗类风湿关节炎合并肺间质病变临床观察[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(7):185-190.
- [105] 李舒, 万磊, 刘健, 等. 雷公藤多苷片对类风湿关节炎合并间质性肺病患者的临床疗效[J]. 中成药, 2023, 45(9):2896-2901.
- [106] 陈红, 王小超, 陶雨菊, 等. 雷公藤多苷联合泼尼松治疗类风湿关节炎肺间质病变的临床疗效[J]. 世界中医药, 2020, 15(4):586-589, 594.
- [107] 马侗, 张哲, 王冬梅, 等. 雷公藤多苷联合艾拉莫德治疗 RA 合并间质性肺病的疗效及对血清 HIF-1 α 、IL-22 水平的影响[J]. 广西医科大学学报, 2019, 36(1):45-48.
- [108] 李松伟, 郭洪涛, 王子华, 等. 雷公藤多苷治疗类风湿关节炎肺间质病变的临床研究[J]. 中华中医药学刊, 2017, 35(7):1662-1664.
- [109] ZHANG M, WANG M, TAI Y, et al. Triggers of cardiovascular diseases in rheumatoid arthritis [J]. Curr Probl Cardiol, 2022, 47(6):100853.
- [110] OZEN G, PEDRO S, MICHAUD K. The risk of cardiovascular events associated with disease-modifying anti-rheumatic drugs in rheumatoid arthritis [J]. Rheumatol, 2021, 48(5):648-655.
- [111] AN J, CHEETHAM TC, REYNOLDS K, et al. Traditional cardiovascular risk factor management in rheumatoid arthritis compared to matched non rheumatoid arthritis in a US managed care setting [J]. Arthritis Care Res, 2016, 68(5):629-637.
- [112] 罗成, 吴聪, 张宁, 等. 中医药联合西医疗法类风湿关节炎伴间质性肺疾病临床疗效和安全性的系统评价[J]. 中国医院用药评价与分析, 2022, 22(6):744-749.
- [113] 王建明, 陶庆文, 张英泽, 等. 补肾祛寒治尪汤联合甲氨喋呤治疗类风湿关节炎肾虚寒盛证的疗效与安全性评价[J]. 中国中西医结合杂志, 2013, 33(5):614-618.
- [114] 赵夜雨, 于静, 姜泉, 等. 益气养阴通络方治疗气阴两虚型类风湿关节炎多中心、双盲、随机对照临床试验 [J]. 中华中医药学刊, 2022, 40(12):57-63.
- [115] 中华中医药学会风湿病分会. 中国类风湿关节炎患者报告的临床结局量表专家共识[J]. 中医杂志, 2018, 59(10):897-900.
- [116] MASKA L, ANDERSON J, MICHAUD K. Measures of functional status and quality of life in rheumatoid arthritis: Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ), Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ), Multidimensional Health Assessment Questionnaire (MDHAQ), Health Assessment Questionnaire II (HAQ- II), Improved Health Assessment Questionnaire (Improved HAQ), and Rheumatoid Arthritis Quality of Life (RAQoL) [J]. Arthritis Care Res (Hoboken), 2011, 63:S4-S13. doi:10.1002/acr.20620.
- [117] 陈勇, 陈志伟, 黄华, 等. SF-36 量表用于类风湿关节炎患者生命质量的研究[J]. 苏州大学学报(医学版), 2005, 25(3):443-445, 450.
- [118] GRIGOR C, CAPELL H, STIRLING A, et al. Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial [J]. Lancet, 2004, 364(9430):263-269.
- [119] GALVAO TF, ZIMMERMANN IR, MOTA LMDA, et al. Withdrawal of biologic agents in rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis [J]. Clin Rheumatol, 2016, 35(7):1659-1668.
- [120] VAN MULLIGEN E, DE JONG PHP, KUIJPER TM,

- et al. Gradual tapering TNF inhibitors versus conventional synthetic DMARDs after achieving controlled disease in patients with rheumatoid arthritis: first-year results of the randomised controlled tara study[J]. *Ann Rheum Dis*, 2019, 78(6):746-753.
- [121] VAN HEUCKELUM M, VAN DEN ENDE CHM, VAN DULMEN S, et al. Electronic monitoring feedback for improving medication adherence and clinical outcomes in early rheumatoid arthritis: a randomized clinical trial [J]. *Patient Prefer Adherence*, 2021, 15: 1107-1119. doi:10.2147/PPA.S297170.
- [122] OMETTO F, RAFFEINER B, AZZOLINA D, et al. Adherence in rheumatoid arthritis patients assessed with a validated Italian version of the 5-item compliance questionnaire for rheumatology[J]. *Clin Exp Rheumatol*, 2019, 37(6):915-922.
- [123] DOUMEN M, DE COCK D, PAZMINO S, et al. Correction to: treatment response and several patient-reported outcomes are early determinants of future self-efficacy in rheumatoid arthritis[J]. *Arthritis Res Ther*, 2021, 23(1):285.
- [124] 胡瑞, 田莹, 黄娅若, 等. 类风湿关节炎患者健康教育需求现状及影响因素[J]. *护理实践与研究*, 2022, 19(22):3342-3347.
- [125] 陈丽. 类风湿关节炎患者心理护理研究进展[J]. *现代中西医结合杂志*, 2006, 15(16):2295-2296.
- [126] MOMOHARA S, IKEDA K, TADA M, et al. Patient-physician communication and perception of treatment goals in rheumatoid arthritis: an online survey of patients and physicians [J]. *Rheumatol Ther*, 2023, 10(4): 917-931.
- [127] 连丽娥, 宋敏敏. 多维度护理干预在老年类风湿关节炎患者中的应用价值[J]. *中外医学研究*, 2020, 18(27):110-112.
- [128] 甘静. 延续性护理干预对类风湿关节炎患者疼痛程度、健康状况与护理满意度的改善效果[J]. *中国医药指南*, 2023, 21(11):5-8.
- [129] XU B, LIN J. Characteristics and risk factors of rheumatoid arthritis in the United States: an NHANES analysis[J]. *Peer J*, 2017, 5:e4035. doi:10.7717/peerj.4035.
- [130] SUGIYAMA D, NISHIMURA K, TAMAKI K, et al. Impact of smoking as a risk factor for developing rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies [J]. *Ann Rheum Dis*, 2010, 69(1):70-81.
- [131] HE J, WANG Y, FENG M, et al. Dietary intake and risk of rheumatoid arthritis: a cross section multicenter study[J]. *Clin Rheumatol*, 2016, 35(12):2901-2908.
- [132] 崔家康, 姜泉. 痰瘀互结证在风湿性疾病中的临床特征及治疗策略[J]. *中国中医基础医学杂志*, 2018, 24(7): 903-904.
- [133] IMOTO AM, AMORIM FF, PALMA H, et al. Evidence for the efficacy of Tai Chi for treating rheumatoid arthritis: an overview of systematic reviews [J]. *Sao Paulo Med J*, 2021, 139(2):91-97.
- [134] 陈园妹, 于环. 八段锦在类风湿关节炎延续护理中的应用[J]. *中国城乡企业卫生*, 2023, 38(12):104-106.
- [135] 杨丽珍, 杨子东. 腰痛宁配合易筋经对类风湿性关节炎的影响[J]. *中国医药指南*, 2013, 11(4):299-300.

Guideline for Integrated Traditional Chinese Medicine Syndrome and Disease Diagnosis and Treatment of Rheumatoid Arthritis (2025)

Project Team of the "Guideline for Integrated Traditional Chinese Medicine Syndrome and Disease Diagnosis and Treatment of Rheumatoid Arthritis", China Association of Chinese Medicine

ABSTRACT In recent years, with the development of diagnostic and therapeutic concepts, the accumulation of evidence from evidence-based medicine, and the updates of domestic and international guidelines, by following the principles of evidence-based medicine, conducting literature searches to objectively evaluate the evidence for integrated traditional Chinese medicine (TCM) syndrome and disease diagnosis and treatment, and thorough expert discussions, the project team revised and updated the TCM syndrome diagnostic criteria and treatment protocols from the 2018 *Guideline for Integrated TCM Syndrome and Disease Diagnosis and Treatment of Rheumatoid Arthritis*, resulting in the *Guideline for Integrated TCM Syndrome and Disease Diagnosis and Treatment of Rheumatoid Arthritis (2025)*, so as to provide a reference for the TCM-based diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis.

Keywords rheumatoid arthritis; integrated syndrome and disease; clinical practice guidelines

(收稿日期: 2025-02-20; 修回日期: 2025-07-02)

[编辑: 焦 爽]